



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN PENERAPAN PANDUAN PRAKTEK KLINIK (PPK), PENGUKURAN
CLINICAL PATHWAY (CP) DALAM MENGURANGI VARIAN DALAM PRAKTEK KLINIK**

SEMESTER I 2026

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LAPORAN PENERAPAN PANDUAN PRAKTEK KLINIK (PPK), PENGUKURAN CLINICAL PATHWAY (CP) DALAM MENGURANGI VARIAN DALAM PRAKTEK KLINIK

SEMESTER I 2026

I. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan yang bermutu memerlukan pelayanan yang efektif, efisien, aman, dan berorientasi pada pasien. Salah satu upaya untuk mencapai pelayanan tersebut adalah melalui penerapan Panduan Praktik Klinik (PPK) dan Clinical Pathway (CP). PPK menjadi acuan bagi Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dalam memberikan pelayanan berdasarkan bukti ilmiah (evidence-based medicine), sedangkan Clinical Pathway merupakan instrumen yang mengintegrasikan pelayanan multidisiplin sehingga proses pelayanan menjadi lebih terstandar.

Clinical Pathway merupakan implementasi Panduan Praktik Klinis (PPK) yang wajib dievaluasi sebagai bagian dari Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP). Evaluasi bertujuan mengurangi variasi pelayanan, meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi, dan keselamatan pasien. Audit ini dilakukan untuk menilai kepatuhan DPJP dan staf medis dalam mengisi CP Tuberkulosis secara lengkap, benar, dan tepat waktu.

II. HASIL PENGUKURAN

A. PENERAPAN PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)/ALGORITME/PROTOKOL

Penerapan PPK dilakukan dengan cara membuat Clinical Pathway (CP) dan kemudian dilakukan pengukuran menggunakan CP secara berkala

Dilakukan dengan mengukur CP INMRS setiap bulan dan mengukur dampaknya terhadap efektifitas biaya setiap 6 bulan. Dilakukan dengan mengukur PPK Prioritas TB dan dampaknya terhadap efektifitas biaya setiap 6 bulan

B. PENGUKURAN CLINICAL PATHWAYS (CP)

1. CP INMRS

1.1 KEPATUHAN TERHADAP CLINICAL PATHWAY TB PARU

I. PENDAHULUAN

Dilakukan pengumpulan dan analisis data pasien tuberculosis (TB) pada bulan Januari – Juni 2026. Dari data tersebut didapatkan 43 rekam medis pasien dengan diagnosis TB.

Dari daftar tersebut dilakukan pemilihan sampel dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria inklusi yang digunakan adalah pasien rawat inap dengan diagnosis TB di Rumah Sakit Prima Husada.
2. Kriteria eksklusi yang digunakan adalah pasien dengan data rekam medis tidak lengkap dan duplikasi data.

Pengambilan sampel melalui *purposive sampling* di Bangsal Isolasi Babussalam. Dari pengambilan sampling tersebut didapatkan 43 rekam medis pasien. Data-data tersebut kemudian dianalisis kesesuaiannya terhadap *clinical pathway* TB, sebagai berikut:

Komponen Audit		REALISASI	
		Jumlah sampel	Persentase
Periode	Januari - Juni 2026	43	
LOS	Rerata LOS	± 5.84 hari	
Dokter	Paru	40	93%
	DPJP selain Paru:	3	6.2%
Data berdasarkan jenis kelamin	Laki-laki	32	65.3%
	Perempuan	11	34.7%
Clinical Pathway	Pemeriksaan dokter	43	100%
	Anamnesis sesuai gejala	43	100%
	Pemeriksaan penunjang		
	Pemeriksaan dahak, biakan, uji kepekaan, TCM, RO thorax (minimal 1)	43	100%
	Terapi Non Farmakologis		
	Edukasi	43	100%
	Terapi Farmakologis		
	OAT sesuai kasus TB	43	100%
	Hasil (outcome)		
	2. Pengobatan fase intensif (2 bulan)	35	81.6%
	3. Pengobatan fase lanjutan (4 bulan)	6	12.3%
	4. Pengobatan Kategori II	0	0%
	5. Dirujuk	12	24,6%
	6. Meninggal	2	6.1%

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. LENGTH OF STAY (LOS)

Dari data tersebut didapatkan rata-rata LOS pasien adalah sebanyak 5.84 hari, menurun bila dibandingkan dengan sebelumnya yaitu 6.88 hari.

2. DOKTER

Dari analisis didapatkan data bahwa sebanyak 40 pasien dengan DPJP dokter spesialis paru, serta 3 pasien dengan DPJP selain dokter spesialis paru.

3. PEMERIKSAAN DOKTER

Dari data pasien tersebut, sebanyak 43 pasien telah diperiksa oleh dokter, dengan realisasi sebanyak 100% dari *clinical pathway*.

4. PEMERIKSAAN PENUNJANG

Dari pemeriksaan penunjang yang dilakukan, 43 pasien dilakukan pemeriksaan penunjang berupa (salah satu dari) pemeriksaan dahak, biakan, uji kepekaan, TCM, atau RO thorax.

5. TERAPI NON FARMAKOLOGIS

Terapi non farmakologis berupa edukasi diberikan pada 43 pasien (100% dari target *clinical pathway*)

6. TERAPI FARMAKOLOGIS

Dari 43 pasien tersebut, 100% pasien diberikan OAT sesuai kasus TB. Hal tersebut sudah sesuai dengan PPK dan *clinical pathway*.

7. OUTCOME

Hasil analisis didapatkan 35 pasien (81.6%) mendapat pengobatan fase intensif (2 bulan), 6 pasien (12.3%) mendapat pengobatan fase lanjutan (4 bulan), serta 2 pasien (6.1%) meninggal.

8. KESESUAIAN DENGAN CP (PER PASIEN)

Dari data yang didapatkan, hanya terdapat 1 dari 43 pasien yang tidak memenuhi target 90% dari kesesuaian dengan CP. Sehingga jumlah pasien yang memenuhi > 90% target CP adalah sebesar 93.0%.

III. KESIMPULAN

1. Dari hasil analisis data 43 sampel pasien tersebut, pada poin pemeriksaan dokter, anamnesis sesuai gejala, pemeriksaan penunjang spesifik, terapi farmakologis, terapi non farmakologis, serta *outcome*, sudah memenuhi target *clinical pathway*.
2. Rerata LOS menurun bila dibandingkan dengan audit periode sebelumnya.
3. Terdapat penurunan defisit tarif BPJS dibandingkan periode sebelumnya.

IV. SARAN

1. Mempertahankan kesesuaian terhadap PPK dan *clinical pathway* > 90%.
2. Mempertahankan/meningkatkan efisiensi LOS.
3. Mempertahankan/meningkatkan efisiensi pembiayaan RS

EXECUTIVE SUMMARY

LAPORAN PENERAPAN PANDUAN PRAKTEK KLINIK (PPK), PENGUKURAN CLINICAL PATHWAY (CP) DALAM MENGURANGI VARIAN DALAM PRAKTEK KLINIK

SEMESTER I 2026

I. Hasil Pengukuran

A. CP INMRS

1. Kepatuhan CP

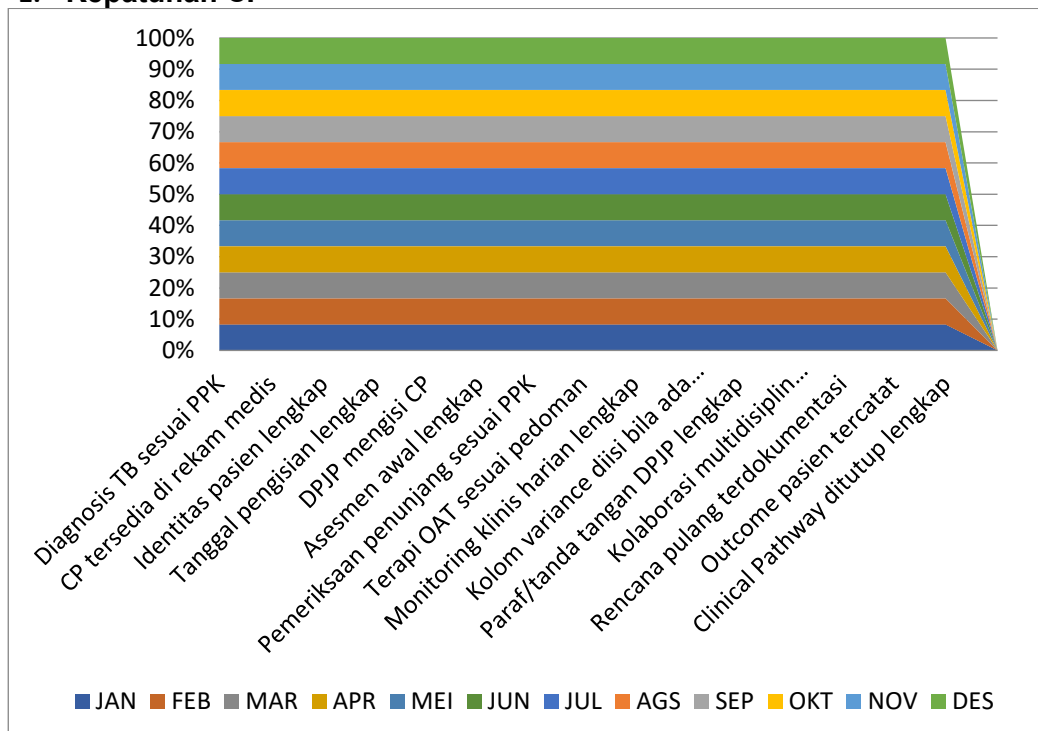
Bulan	TB	Rata-rat capaian	Target
Jan	85%	90.3%	90%
Feb	86%	92%	90%
Mar	92%	93%	90%
Apr	86%	90,6%	90%
Mei	91%	92%	90%
Jun	92%	93%	90%

Keterangan :

- Rata – rata kepatuhan CP INMRS di Bulan Juni yaitu sebesar 93,3%.
- Di Bulan Juni terdapat penambahan monitoring kepatuhan CP untuk diagnosis TB.

B. CP PRIORITAS

1. Kepatuhan CP



Target	90	90	90	90	90
Januari-Juni 2026	100	100	100	100	100

Keterangan:

Rata-rata kepatuhan PPK TB Periode Januari – Juni 2026 yaitu sebesar 100%.

2. Analisa/Permasalahan

A. CP INMRS

1. Terjadi penurunan LOS 0,35 hari dibandingkan periode triwulan sebelumnya.

3. Kesimpulan

A. CP INMRS

1. Berdasarkan analisa kepatuhan CP INMRS di bulan Juni 2026 (93%), tingkat kepatuhan PPK/CP dalam pemberian pelayanan kepada TB mencapai target > 90%.
2. Dengan adanya peningkatan kepatuhan terhadap CP, maka biaya dan sumber daya rumah sakit yang digunakan pasien lebih efektif dan efisien.

B. PPK Prioritas TB

1. Berdasarkan hasil audit PPK Prioritas TB, didapatkan hasil kepatuhan pada diagnosis TB mencapai 100%.
2. Tidak ditemukan adanya variasi dalam pelayanan diagnosis-diagnosis tersebut.
3. Dengan adanya kepatuhan terhadap CP, maka biaya dan sumber daya rumah sakit yang digunakan pasien lebih efektif dan efisien.

4. Rencana Tindak Lanjut

1. Mempertahankan kepatuhan terhadap target > 90% pada seluruh indikator Panduan Praktek Klinis dan *clinical pathway*.
2. Mempertahankan/meningkatkan efisiensi layanan pasien terutama BP

Malang, 02 Februari 2026

Ketua Komite Medik



dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An-TI

Ketua SMF Penyakit Paru



dr. Andy, Sp. P(K)

PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes

